TÓM TẮT LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 4 Đục thủy tinh thể

Tóm tắt từ bài giảng 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf (23 trang) · Giữ ý chính và dấu hiệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ
2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ
3. TRIỆU CHỨNG
4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ
5. BIẾN CHỨNG
6. ĐIỀU TRỊ

1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ

- **3 phần chính: bao**, **vỏ**, **nhân** thủy tinh thể (TTT).
- **Thấu kính hội tụ, trong suốt**; **không có mạch máu, thần kinh**; công suất khúc xạ **khoảng +20D**.
- **Bao TTT:** màng **bán thấm** với nước và điện giải. **Biểu mô TTT:** chuyển hóa, phân bào, biệt hóa thành **sợi TTT**. **Vỏ và nhân:** tạo từ sợi TTT; **sợi cũ nén dần vào trong thành nhân**.
- **Vai trò:** duy trì **độ trong suốt**, **khúc xạ ánh sáng**, thực hiện **chức năng điều tiết**.

2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ

- **Nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực** trên thế giới và Việt Nam.
- Gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt **trên 50 tuổi**; **nữ chiếm 2/3**.
- **Yếu tố nguy cơ: tuổi**, **dùng steroid kéo dài**, **hút thuốc lá**, **tiếp xúc tia UV**, **uống nhiều rượu bia**, **phẫu thuật nội nhãn**, **bệnh lý toàn thân**.

3. TRIỆU CHỨNG

- **Nhìn mờ** từ từ; **không đỏ, không đau, không cộm xốn**.
- **Lóa mắt**, **song thị một mắt**, **cận thị giả**.

4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ

Hình thái	Đặc điểm
Đục nhân (do tuổi)	Tiến triển **chậm, 2 mắt**, có thể không cân đối; ảnh hưởng **nhìn xa**; **cận thị giả**
Đục vỏ (do tuổi)	**Luôn ở 2 mắt**, thường không cân xứng; **lóa mắt**; dễ gây **tăng nhãn áp thứ phát**
Đục dưới bao sau (do tuổi)	Gặp ở **người trẻ**; **ra sáng nhìn mờ hơn trong tối**; khám dưới **đèn khe và đồng tử giãn**
Sau viêm màng bồ đào	Viêm kéo dài không kiểm soát; **dính mống mắt vào mặt trước TTT**; phẫu thuật phức tạp, kết quả không cao
Đái tháo đường	Người trẻ: **đột ngột, tiến triển nhanh**; người già: xuất hiện **sớm hơn**, giống đục do tuổi
Hạ calci huyết	Thường 2 mắt; **chấm đục óng ánh** mặt trước và sau TTT
Do thuốc	**Corticosteroid**, thuốc hướng thần (**phenothiazine**), thuốc tim mạch (**nifedipine, methyldopa**)
Đụng dập nhãn cầu	Nhanh hoặc âm ỉ; **vòng Vossius**, **đục hình sao**, bán lệch TTT
Chấn thương xuyên	Đục vỏ tại vị trí rách → đục toàn bộ; kèm đứt chân mống, **dị vật nội nhãn**

Hình thái	Đặc điểm
Chấn thương khác	Bức xạ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, hóa chất, điện
Bẩm sinh	1 hoặc 2 mắt; nguy cơ: cha mẹ **giang mai**, đồng huyết thống, mẹ nhiễm **Rubella 3 tháng đầu**; **mổ càng sớm càng tốt, lý tưởng trước 3 tháng tuổi**

5. BIẾN CHỨNG

- **Tăng nhãn áp thứ phát**.
- **Vỡ bao TTT** → nhân rơi vào **dịch kính** hoặc **tiền phòng** → **viêm màng bồ đào kèm tăng nhãn áp**.
- **Giảm thị lực nghiêm trọng**.

6. ĐIỀU TRỊ

- **Nội khoa:** giai đoạn **chưa có chỉ định phẫu thuật**: thuốc nhỏ (Kary Uni, Quinax, Catacol...); **giả cận thị** → **đeo kính tạm thời**.
- **Ngoại khoa:**
  - Phẫu thuật lấy TTT **trong bao**.
  - Phẫu thuật lấy TTT **ngoài bao**.
  - **Tán nhuyễn TTT bằng siêu âm (Phaco)**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf khi cần chi tiết.